SDD 124 Sujet n°1

Spécialité : Psychiatrie

Date : 25/09/2023
Auteur : ELAYLI Robin (DES de Psychiatrie - ECN 2023)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES de Médecine interne - ECN 2023), Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	ITEM 63 Troubles schizophrénique
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 124 idées délirantes
Matériel nécessaire à la station	- Une chaise, un bureau - Un IPAD pour l'examinateur
Contexte de la station	Consultation d'un jeune homme de 25 ans accompagné de sa soeur pour des idées délirantes

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un.e médecin généraliste
Vous recevez M. Martel Henri, âgé de 25 ans dans votre cabinet, accompagné de sa grande sœur Mme. Martel Emma, 28 ans.

M. Martel présente d'après sa soeur des "idées folles".
La sœur vous indique en effet que son frère tient un discours complètement délirant depuis quelques mois, et se fait beaucoup de soucis pour lui…
Alors que vous essayez de discuter avec son frère, celui-ci ne vous répond pas, et sa sœur vous dit qu'il ne vous parlera pas, et qu'elle est la seule à qui il parle et partage ces fameuses idées.

D'après sa sœur, monsieur Martel n'a pas d'antécédent notable personnel ou familial, et ne prend aucun traitement, ni drogue. Il est calme et reste assis.

Vous pensez à un trouble schizophrénique. Lorsque vous demandez à monsieur Martel s'il est d'accord pour que ce soit sa sœur qui réponde aux questions, il regarde sa sœur et lui demande "tu peux le faire ? ". Elle lui dit qu'elle s'en occupe.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Caractériser les idées délirantes du patient

- Réaliser l'interrogatoire nécessaire pour poser le diagnostic de trouble schizophrénique

- Enoncer à l'examinateur le type du trouble schizophrénique que vous avez identifié

Vous ne devez pas :
- Rechercher des hallucinations ou des idées suicidaires
- Réaliser un examen clinique
- Vous occuper de la prise en charge ou l'orientation de ce patient et de sa sœur.
- Faire une annonce diagnostique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Caractérisé des idées délirantes			
1.	Demande la date de début de ces idées délirantes	1pt	☐
2.	Demande le thème des idées délirantes	1pt	☐
3.	Recherche le mécanisme des idées délirantes	1pt	☐
4.	Recherche la systématisation des idées délirantes	1pt	☐
5.	Recherche l'adhésion du patient à ces idées délirantes	1pt	☐
Recherche un syndrome négatif			
6.	Recherche les éléments affectifs du syndrome négatif (0,5 pt par élément) : ● Recherche une impression de froideur/indifférence de la part de ces proches ● Recherche une absence de réaction aux évènements extérieurs	1pt	☐
7.	Recherche les éléments cognitifs du syndrome négatif : ● Problèmes de conversation de l'entourage avec le patient OU des réponses brèves et évasives de la part du patient	1pt	☐
8.	Recherche les éléments comportementaux du syndrome négatif (0,5 pt par élément) : ● Recherche une incapacité à planifier ces actions ● Recherche une incapacité à commencer quelque chose ● Recherche une incapacité à maintenir ces actions	1pt	☐
Recherche un syndrome de désorganisation			
9.	Recherche dans le discours du patient (0,5 pt par élément) - La présence d'un manque de logique dans le discours tenu par le patient (ambivalence, rationalisme morbide, raisonnement paralogique, non compréhension du 2nd degré) - Un débit verbal anormal (barrage, fading, bégaiement intermittent)	1pt	☐

	- La présence d'un problème au niveau du vocabulaire employé par le patient (Néologisme, paralogisme, jargonophasie, maniérisme) - Des propos décousus, qui s'enchaînent sans cohérence - Une impossibilité de remettre en cause le discours		
10.	Recherche au niveau du ressenti émotionnel du patient (0,5 pt par élément) : - Ambivalence : Expression de 2 sentiments opposés à l'égard d'un même élément - Expression d'affect inadapté	1pt	☐
11.	Recherche au niveau du comportement du patient (0,5 pt par élément) : - Un maniérisme - Un manque de coordination - Des mouvements ou mimiques brutal et imprévisible	1pt	☐
12.	Recherche des altérations des fonctions cognitives (0,5 pt par éléments) : ● Recherche des actions non cohérentes avec le contexte social (trouble des fonctions exécutives) ● Recherche des oublis dans l'expression d'événement récent de la vie quotidienne (troubles de mémoire verbale) ● Recherche des problèmes d'attention ● Recherche un ralentissement à prendre en compte les informations, l'impression que le patient est ralenti	1pt	☐
Diagnostic			
13.	Recherche la durée et la temporalité sur laquelle les 3 syndromes sont présents en proportion significative (A le point uniquement si recherche pour les 3)	1pt	☐
14.	Recherche des difficultés dans un domaine majeur de fonctionnement : travail ET relation ET soins personnels	1pt	☐
15.	Recherche la durée de ces difficultés ET évoque le diagnostic de schizophrénie	1pt	☐
	Sous-total	**…/15**	

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL (max 20 items)	…/19 points

Éléments de rétroaction :

SUJET TRÈS DIFFICILE :
On est ici dans une situation d'un entretien psychiatrique avec un tiers. Bien que cela soit rare, c'est une situation qui est possible, et cela rend alors l'interrogatoire psychiatrique complexe pour vous car vous devez connaître la sémiologie à rechercher, mais aussi savoir quelles questions poser pour la faire ressortir sans perdre trop de temps (dans le contexte des ECOS. Dans la pratique clinique, vous avez plus de temps pour cela)… C'est plus complexe lors d'un interrogatoire avec un.e patient.e psychiatrique car dans ce cas vous devez rechercher les signes sur les patients.es via des questions différentes.

Voici donc comment rechercher les syndromes des troubles schizophréniformes en interrogeant un tiers, ou en interrogeant un patient :
- **Syndrome positif** : 2 possibilités :
  - Soit les symptômes sont le point de départ des sujets basés sur les SDD 124 Idées délirantes et SDD 122 Hallucination.
  - Soit vous devez le rechercher. Les hallucinations et idées délirantes sont souvent problématiques pour le/la patient.e, et donc souvent une cause de gêne (la majorité du temps, c'est même le motif de la consultation)

- **Syndrome négatif** (A noter que certaines questions peuvent aussi donner des signes d'anamnèse de désorganisation)

	Questionner un tiers	Questionner un patient
Affectif	Rechercher une froideur et un détachement. *"Vous semble-il froid ou distant par rapport aux autres ou à ce qui se passe autour de lui ? "*	- Observer la réaction du patient selon ce qu'il raconte. On recherche un visage inexpressif, une voix monotone. - Pour l'impression de froideur, voir si le patient réagit à vos propos, s'il évite de discuter avec vous
Cognitif	Rechercher des difficultés à parler avec le sujet *"Avez vous du mal à discuter avec lui ? Pourquoi donc ?"*	- Notez si le patient vous donne des réponses brèves, évasives, s'il est difficile de converser avec lui. - Lui demander s'il a du mal à discuter avec les autres, pour ensuite lui demander depuis combien de temps il a ces difficultés (cela permet de rechercher une durée)
Comportement	- Demander ce qu'il fait de ces journées - Demander s'il a du mal à prévoir, débuter et/ou à continuer des actions	

- **Syndrome de désorganisation**

	Questionner un tiers	Questionner un patient
Discours	- Demander si le tiers trouve qu'il y a un manque de logique dans le discours, s'il ne comprend pas le 2nd degré	Essayer de trouver une absence de logique dans son discours : ● Demander la signification d'un proverbe (recherche d'une absence de compréhension du 2nd degré) ● Demander le lien entre 2 évènements rapportés par un patient (recherche un problème de logique)
	- Demander si des éléments de son vocabulaire sont bizarres " Son vocabulaire à t'il changé récemment ? Y a t-il des mots qui ne sont pas cohérents quand il parle ?"	Analyser le vocabulaire employé, et relevé les éléments bizarres : ● Emploi de mot inconnu (néologisme) ● Emploi de mot connu mais avec un sens différent de celui classiquement admis (paralogisme) ● Emploi de vocabulaire très soutenu, très maniéré
	- Demander s'il y a un problème dans le débit verbal du patient (ne fini pas ces phrases, bégaie) "Lorsqu'iel parle, lui arrive t'il de bégayer, ou de ne pas finir ces phrases ?"	Analyser le débit verbale du patient : - Fading (Arrêt progressif d'une phrase - Barrage (arrêt brutal d'une phrase) - Bégaiement
	- Demander si lors de conversation avec le/la patient.e, les idées s'enchaînent sans logique ni idée directrice " Lorsque vous discutez avec lui/elle, change t-il rapidement de sujet sans qu'il n'y ait de lien avec l'idée d'avant?"	Analyser l'enchaînement des idées dans le discours des patients.es
	- Demander si il est possible de remettre en cause le discours du patient, de le raisonner "Arrivez-vous à le raisonner ? "	Essayer de raisonner le/la patient.e (sans chercher à le convaincre, juste pour identifier une absence de souplesse dans la pensée)
Affect	- Recherche de l'expression de sentiments contradictoires envers des éléments " Exprime t-il 2 émotions opposées pour une même chose ?"	Rechercher l'ambivalence affective dans le discours des patients.es (en analysant son discours ET en lui posant la question) "Vous arrive t'il d'avoir des sentiments opposés pour une même chose ?"

	- Recherche une incohérence entre le discours qu'iel tient et le sentiment que dégage le/la patient.e "A t'iel des réactions qui semblent incohérentes avec le discours qu'iel tient, ou avec le contexte ?"	Analyser les réactions du patient à son propre discours (sourit quand parle de chose triste, rit sans qu'il n'y est de raison à cela) Demander s'iel a eu des remarques sur des réactions qui ont été qualifié de incompréhensible ou non logique
Comportement	- Demander si le/la patient.e à des gestes trop maniérés ou des difficultés dans sa motricité. - Demander s'iel a des mouvements brutaux inexplicables	- Analyser la façon dont le patient bouge, marche, utilise son corps quand parle - Lui demander s'iel a des difficultés motrices ou s'iel a des mouvements brutaux inexpliqués

MAIS ATTENTION,le plus gros piège vient à la fin de l'entretien !!!!

- Pour poser le diagnostic correct, il FAUT bien définir la durée et la temporalité des syndromes. En effet pour diagnostiquer un trouble schizophréniforme, il faut qu'au moins 2 syndromes (positif, négatif, désorganisation) soient associés sur une période d'au moins 1 mois

- Pour savoir quel trouble schizophréniforme est ici présent cependant, il faut rechercher la durée des difficultés engendrées dans domaine majeur du fonctionnement (travail, relations interpersonnelles, soins personnel) engendré par ce trouble schizophrénique :

- Schizophrénie si difficultés persistantes au moins 6 mois
- Trouble psychotique bref = Si au moins 1 jour, mais moins d'un mois
- Trouble schizophréniforme = Difficultés engendrées entre 1 – 6 mois

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes Mme Martel Emma, la soeur de Mr. Martel Henri

Plan de la station ECOS :

En face du/de la candidat.e, assis sur une chaise, devant un bureau

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Très bien docteur, mon petit frère est d'accord pour que je réponde à vos questions à sa place. Posez-moi vos questions.

Identité du patient :

Mr. Martel Henri 25ans Homme 1m75 65 kg

Mode de vie :

Au chômage depuis quelques mois, dans la restauration auparavant
Célibataire
Vit en colocation avec sa soeur
Ne fume pas, ne boit que lors de soirée et en petite quantité, ne consomme pas de drogue
Pas d'allergie notable
Pas de traitement ni d'antécédent notable du patient

Comportement global :

Inquiète, anxieuse, à l'écoute, réactive

Antécédents personnels :

Rien

Antécédents familiaux :

Rien

Médicaments :

Rien

A propos du syndrome positif :

- Durée de ces idées : "Cela fait bien 9 mois maintenant"
- Contenu des idées délirantes : "Il me dit qu'il pense avoir trouvé la solution pour sélectionner les gens selon leur patrimoine divin…je vous avoue ne pas trop comprendre ce que c'est, il me dit que c'est la valeur divine d'une personne"
- Comment se forment ces idées, sur quoi se base-t-il pour dire cela "Il me dit qu'il sait, qu'il ne saurait pas expliquer pourquoi mais il sait"
- Croyance du sujet en ses idées : "Je ne sais pas il me dit qu'il est sûr de lui mais qu'il ne comprend pas trop lui même, mais il sait"

- Si on parle d'adhésion ou de systématisation : "Qu'est ce que cela signifie ?"

A propos du syndrome négatif :

- Contact du patient avec les tiers : "Il est très éloigné, comme inaccessible, son visage est figé peu importe ce qu'il dit"
- Difficulté de discuter avec lui "C'est complexe pour moi déjà, mais en plus avec les autres il refuse de leur parler"
- Ce qu'il fait de ces journées : "Je dois le réveiller sinon il ne fait rien, il reste au lit. Et même quand je le motive à faire des choses, il ne les finit jamais"
- Durée de l'inactivité du patient : 1 an
- Durée de l'impression de distance entre le patient et les tiers : "Cela fait longtemps que je le trouvais plus froid et plus dur de parler avec lui, je dirais bien 2 ans"

apragmatisme, aboulie : "Je ne sais pas ce que c'est, qu'est ce que cela signifie ? Et comment cela se manifesterait si cela était présent ?"

A propos du syndrome de désorganisation :

Depuis 9 mois environ, elle observe :
- Des modification dans son discours :
    - Changement dans son vocabulaire : "Langage très soutenu, il utilise des mots que je ne comprends pas, par exemple un Ardvan, je ne connais pas"
    - Changement dans son comportement :
        - "il parle aussi beaucoup avec ces mains en plus de cela, avec de grands mouvements très précieux"
        - "Aussi parfois il rit sans contexte, sans explication"
    - Débit verbal changé : "Oui il s'arrête parfois au milieu des phrases brutalement sans raison"
    - "Impossible de le raisonner"
    - "Il n'y a pas de logique entre ces idées"
    - "Il exprime parfois de la joie et de la tristesse en même temps quand il parle de son vécu actuel"
- Au niveau comportemental : Pas de mauvaise coordination motrice, pas de parakinésie (décharge motrice imprévisible), pas de paramimie (mimique déformant le visage)
- Au niveau des fonctions cognitives :
    - Pas de perte de mémoire rapporté, pas de ralentissement dans sa vitesse à intégrer les informations
    - Présence de problème pour prendre en compte le contexte social, difficulté d'attention
- Si parle de fonctions exécutives : "Je ne sais pas ce que c'est, mais si elles étaient anormales cela se manifesteraient comment ?"
- Si parle de parakinésie, paramimie, rationalisme morbide, raisonnement paralogique, altération de capacité d'abstraction, ambivalence, barrage, fading : "Je ne sais pas ce que c'est, qu'est ce que cela signifie ? Et comment cela se

manifesterait si cela était présent ?”

Concernant les difficultés dans des domaines majeures de fonctionnement

Si demande s’il y a eu des répercussions sur son quotidien : “Cela dépend de quoi vous parlez. Niveau travail il a été viré car ne venait plus, niveau social il est très isolé maintenant”
- Au niveau du travail : “A été viré il a 8 mois car il ne venait plus à son travail”
- Au niveau relationnel : “Il a perdu beaucoup d’amis et ne sort plus”
- Au niveau des soins personnels : “ Il continue à se laver de lui même mais ne cuisine plus et ne se gère plus financièrement parlant”

Réponses aux questions

- Si pose des questions sur l’humeur du patient : “Je n’arrive pas à savoir car il exprime à la fois de la joie et de la tristesse sur sa condition actuelle”
- Si pose des questions sur le sommeil du patient : “Il dort tôt, mais reste au lit le matin si je ne le force pas à se lever”

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Acteur.trice placé.e en face des candidats.es, avec un bureau entre eux

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur
- Un bureau
- 2 chaises